

14 - 01-Révision Sémiologie psychiatrique (Teams) - Pr. ADALI

(0:02 - 0:15)

Bonjour Madame, oui Madame. Prépare de désactiver de vos micros et de répondre par message. Comme ça, ça ne va pas être d'accord.

(0:17 - 0:37)

Donc, vous me répondez, si vous voulez, par messagerie COK, prière d'écrire, d'accord. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va avoir la séance interactive concernant l'entretien psychiatrique.

(0:37 - 3:52)

la sémiologie psychiatrique. Donc s'il vous plaît, je commencerai par les questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours? Déjà, est-ce que l'écran est partagé avec vous? Est-ce que vous avez la diapositive objective du cours sur votre PC? D'accord, donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, on commence dès maintenant.

Est-ce que vous avez des questions particulières? Pour répondre à Zahid Sadri, quelle est la différence entre le tic et le comportement compulsif? Le comportement compulsif vient répondre à une obsession. C'est un exemple simple. Quelqu'un qui a une obsession de saleté, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche pour lui est sale.

Donc il aura un comportement compulsif de nettoyage excessif. Par contre, un tic, c'est un mouvement involontaire, anormal, qui ne répond pas à une idée obsessionnelle. Est-ce que vous comprenez? Le comportement compulsif est toujours associé à une idée obsessionnelle.

Et si le patient n'exécute pas ce comportement compulsif de nettoyage excessif, il va être angoissé, parce que l'idée que tout est sale, par exemple, entraîne chez lui une angoisse et de l'anxiété importante. Et pour apaiser cette anxiété, il est obligé d'exécuter un comportement compulsif qui est le nettoyage excessif, c'est-à-dire qu'il peut se laver les mains dix fois ou vingt fois. D'accord? Par contre, le tic est un mouvement anormal, qui ne vient pas répondre à une idée obsessionnelle.

(3:55 - 7:49)

Pour Hailey, la coadole qui pose la question, est-ce que l'homosexualité fait partie des perversions sexuelles? Non, dans le DSM, dans les critères DSM, c'est-à-dire le DSM, c'est le manuel statistique et diagnostique des maladies mentales, c'est-à-dire le manuel où vous trouverez toutes les pathologies psychiatriques, c'est un manuel universel, dans aucune classification des maladies mentales, on ne trouverait pas l'homosexualité. Et elle était considérée comme étant une perversion sexuelle, mais actuellement, elle ne l'est plus. Et vous allez voir en long et en large cette répartition des perversions sexuelles dans le cours de la pathologie psychiatrique en cinquième année.

D'accord? J'espère que j'ai répondu avec vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, pour l'entretien psychiatrique, il est en termes de, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire lors de l'entretien psychiatrique? C'est à peu près la même chose que les examens des autres organes que vous avez vus, notamment l'examen cardiovasculaire, pleuropulmonaire, c'est-à-dire que ça doit répondre à une logique. Et à la fin de l'examen, vous devez faire une conclusion clinique et évoquer des diagnostics.

Pour le principe, c'est la même chose. Par contre, l'entretien psychiatrique a certaines particularités. C'est que le diagnostic, on l'a par d'autres moyens.

D'abord, il faut des conditions particulières à l'entretien psychiatrique qui sont, pardon, excusez-moi, voilà, un endroit calme. Il faut présenter le malade et se présenter soi-même et définir votre rôle en tant que médecin. La demande de soins est différente par rapport aux autres spécialités parce que la demande de soins peut ne pas seulement émaner du patient lui-même, mais aussi de son entourage.

Quand il y a un patient qui arrête son traitement, qui devient agité ou agressif, ou bien la demande de soins peut émaner aussi des autorités. On peut vous ramener un patient qui présente des troubles du comportement dans la rue. On vient vous le ramener à l'hôpital pour prise en charge.

(7:56 - 10:51)

Dans un premier temps, lors de l'entretien psychiatrique, il faut laisser d'abord le patient parler parce que ce temps d'écoute est important, parce que de cette façon-là, vous allez savoir quelle est la demande du patient, pourquoi il vient vous voir. Après, on relance par ce qu'on appelle les questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est des questions qui laissent au patient l'opportunité de s'exprimer librement.

Je crois qu'on avait vu les questions ouvertes dans le cours des techniques de communication en première année. C'est contraire aux questions fermées qu'on utilise quand on a besoin d'informations précises de la patiente. Après, on évalue l'évaluation de la psychopathologie, c'est-à-dire faire sortir, évaluer les symptômes qu'il présente, les signes qu'il présente et évaluer aussi la qualité de l'entourage.

Est-ce que c'est un entourage soutenant ou déstabilisant? À la fin, on apporte aussi un feedback au patient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a trouvé, quel est le diagnostic auquel on a pensé. L'asémiologie psychiatrique adulte, l'entretien psychiatrique, suit une certaine chronologie. D'abord, la première des choses qu'on voit chez un patient, qu'on observe chez un patient, c'est sa présentation, c'est-à-dire comment il est habillé, son hygiène, son comportement, c'est-à-dire comment il entre, comment il s'assoit.

Tous ces symptômes-là ont une importance dans l'évaluation et le diagnostic. Parce qu'un patient, comme j'ai mis dans l'exemple, qui est très sale et qui porte une tenue inadaptée,

imaginez qu'en plein hiver, on vous le ramène habillé en short et en t-shirt ou en vêtements très légers. Donc, c'est ce qu'on appelle une tenue inadaptée à la situation.

(10:52 - 12:10)

Donc, on est plus ou moins, je dis bien orienté, c'est-à-dire on ne peut pas évoquer un diagnostic, par exemple d'une maladie comme la schizophrénie, rien que sur la présentation. Mais sur la présentation, on est orienté vers un diagnostic. On analyse aussi le contact du patient.

Il y a plusieurs types de contacts et chaque type de contact est caractéristique d'une pathologie particulière. Par exemple, l'indifférence, la froideur. Vous voyez comme si le patient était dans une bulle, il ne communique pas avec vous.

Ce type de contact-là est caractéristique de la schizophrénie. La mimique aussi, parce que la mimique reflète l'affectivité et les émotions du patient. On peut trouver une hypermimie ou une hypomimie en fonction aussi des diagnostics.

(12:11 - 13:23)

Et deuxième élément qu'on analyse, c'est le comportement. Il y a ce qu'on appelle les excès du comportement moteur, l'agitation, l'impulsion, le rhapsus qui est une réponse à l'instant dans l'instant. C'est un geste qui est soudain en réponse à une situation, en réponse à une émotion, à une pensée particulière.

Les compulsions et l'éthique, je viens de les expliquer. En plus des excès du comportement moteur, il y a aussi les déficits du comportement moteur, notamment le ralentissement psychomoteur ou moteur avec une lenteur des mouvements qui est caractéristique de la dépression. On analyse aussi les troubles des conduites sociales.

(13:26 - 15:15)

Dans l'analyse des troubles des conduites sociales qui sont atype de fugue, agression, tentative de suicide, dans l'analyse de ces troubles-là, il faut noter le degré de conscience du sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il est conscient de ce qu'il a fait ou pas et de ses motivations. Parce qu'un patient qui va agresser physiquement quelqu'un, il peut être délirant, il peut être persécuté par cette personne. Il aura l'impression, peut-être que c'est un patient qui a l'impression que cette personne-là lui veut du mal, veut le tuer.

Donc cette agression n'est au fait pour le patient qu'une façon de se défendre contre un persécuteur présumé. On analyse aussi les troubles des conduites instinctuelles. Les conduites instinctuelles, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est la sexualité.

Pour l'alimentation, parmi les troubles, on peut trouver l'anorexie qui est un symptôme qui correspond à une perte de l'appétit. Par contre, l'anorexie mentale, c'est un trouble spécifique,

c'est une privation mais qui est volontaire de la nourriture. C'est pas que la patiente ou le patient n'a pas d'appétit mais qu'il ne veut pas manger parce qu'il se croit très obèse, donc il a besoin de suivre un régime pour maigrir.

(15:17 - 18:24)

En plus des restrictions alimentaires, il y a ce qu'on appelle aussi les excès alimentaires, c'est l'hyperphagie et la boulimie aussi. La boulimie est caractérisée par une ingestion rapide, c'est-à-dire que le patient va ingérer de façon très rapide et incontrôlable une grande quantité d'aliments. Après cette ingestion-là, il va culpabiliser parce qu'il a beaucoup mangé, qu'elle va prendre du poids, c'est surtout des patientes.

Pour parier à cette prise de poids, il s'en suit ce qu'on appelle des comportements de contrôle de poids, comme les vomissements provoqués, répétés, pour ne pas prendre de poids. Il y a ce qu'on appelle les aberrations alimentaires, c'est le fait de s'alimenter avec une substance impropre à l'alimentation, comme la terre, comme les matières fécales, etc. C'est caractéristique de certaines pathologies, comme la schizophrénie.

Dans les troubles des conduites sexuelles, il y a ce qu'on appelle les déficiences ou insuffisances sexuelles. C'est une déficience ou une insuffisance dans l'acte sexuel en lui-même qui est, par exemple, un défaut d'érection chez l'homme ou de l'éjaculation, la frigidité qui est une absence d'orgasme chez la femme. J'ai une question d'un deux questions.

D'abord, Daniel, est-ce qu'une boulimie peut être associée à une anorexie mentale? Oui, l'association de boulimie et anorexie est très très fréquente et vous allez voir ça en détail dans le cours de pathologie psychiatrique en cinquième année. Pour Sonia, quelle est la différence entre boulimie et gloutonnerie? La gloutonnerie, c'est le fait de manger rapidement et on excède tout ce qu'on trouve. Par contre, dans la boulimie, c'est une ingestion d'une grande quantité d'aliments mais qui se suit de comportements de contrôle de poids.

(18:25 - 22:52)

Le plus fréquent, c'est les vomissements provoqués. Dans la gloutonnerie, il n'y a pas de comportement de contrôle de poids, c'est-à-dire il n'y a pas de vomissements provoqués. D'accord? Donc, la différence entre les deux.

Dans la gloutonnerie, on trouve très rarement un sentiment de culpabilité important. Par contre, dans les crises boulimiques, après la crise, il y a toujours une culpabilité et un sentiment de honte important chez la patiente. Il y a aussi les perversions sexuelles, c'est-à-dire que le plaisir sexuel est atteint par d'autres moyens, autre que le rapport sexuel normal, comme l'exhibitionnisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir le plaisir, qui ne peuvent avoir le plaisir qu'avec l'exhibitionnisme.

D'accord? Dans la nécrophilie, c'est-à-dire que le plaisir sexuel n'est atteint ou bien principalement avec un cadavre humain. C'est ça les perversions sexuelles. Il y en a plusieurs.

J'ai donné juste des exemples. Les excès sexuels, c'est une impulsion à répéter un acte sexuel avec une fréquence inhabituelle. Dans les troubles instinctuels, on trouve aussi les troubles du sommeil.

D'abord l'insomnie, qui est une diminution de la durée et de la qualité du sommeil. La durée, c'est le nombre d'heures. La qualité du sommeil, c'est la récupération après le sommeil.

C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un, quand il se réveille le matin, il se réveille en forme, prêt à accomplir ses activités quotidiennes ou bien c'est un sommeil qu'on appelle non récupérateur. C'est-à-dire que le patient a toujours envie de dormir, même s'il peut passer des heures et des heures au lit. Mais c'est un sommeil qui n'est pas récupérateur.

Dans la dépression, il y a plusieurs types d'insomnie. Par exemple, dans la dépression, on trouve l'insomnie du petit matin. C'est que le patient se réveille au petit matin, vers 4h-5h et puis il ne peut plus se ré-endormir.

L'hypersomnie, c'est une augmentation importante des heures de sommeil. L'héparasomnie, c'est la survenue d'un événement anormal pendant le sommeil, comme le bruxisme pendant le sommeil. Pour répondre à la question de Daniel, oui, le somnambulisme est une forme de parasomnie.

Là encore, je crois que vous allez le faire dans le cours des troubles de sommeil en quatrième année, je crois, en neurologie. Vous allez voir ça vraiment en détail. Pour répondre à votre question, oui, le somnambulisme est une forme de parasomnie.

Maintenant, on va analyser la pensée. En analysant la pensée, on analyse d'abord le cours de la pensée, c'est-à-dire le rythme. Est-ce que c'est un rythme accéléré de la pensée ou bien un rythme qui est ralenti? Le rythme accéléré, on l'appelle une tachépsychie avec une fuite des idées, c'est-à-dire que le patient a plusieurs idées qui sont en enchaînement logique.

(22:53 - 30:35)

Mais ces idées défilent très rapidement, qu'il n'a pas le temps de terminer sa première idée, qu'il passe à la deuxième. Et il ne termine pas la deuxième idée, il passe à la troisième. Ça va se manifester sur le plan parole par ce qu'on appelle la logurée.

C'est un patient qui va parler très, très, très vite. Et parfois, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit parce que justement, il ne termine pas ses idées. D'accord? La bradypsychie, par contre, se manifeste sur le plan parole par ce qu'on appelle la bradyphémie, c'est-à-dire un rythme de la parole qui est très, très, très ralenti.

Le ralentissement de la pensée est caractéristique de la dépression. Après le rythme, c'est-à-dire de la pensée, maintenant, on va voir la continuité de la pensée. Il y a ce qu'on appelle un barrage.

Le barrage, c'est une interruption brutale du discours. Je vais vous lire la définition du barrage en faisant un barrage. D'accord? Interruption totale du discours, puis une reprise après quelques instants sur le même sujet ou sur un autre.

Donc, j'ai fait ici un barrage. Par contre, le fadine, c'est un arrêt progressif de la pensée. La parole devient très lente pour finir par s'épuiser.

Bien, en lisant le fadine, je vais vous faire un fadine. Le fadine, arrêt progressif du cours de la pensée, la parole devient lente. Donc, vous voyez, c'est très, très caractéristique.

Le barrage et le fadine sont très caractéristiques de la schizophrénie. La diffluence, c'est une dispersion, ce sont des idées qui sont très désorganisées, anarchiques, qui ne respectent ni logique ni cohérence et sont objets clairement perceptibles. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est désorganisée, totalement désorganisée.

La fuite des idées, ça répond de la même façon à l'attaque psychique. C'est, comme on a dit, un enchaînement très rapide des idées. Le patient passe d'une idée à l'autre, ne se concentre pas sur un thème précis.

Maintenant, on va passer au trouble du contenu de la pensée. D'abord, les phobies. Les phobies, c'est une crainte irraisonnée d'un objet qui est sans danger, au fait, comme la phobie de certains animaux, comme les chats, comme la phobie sociale qui est la phobie des gens.

Les obsessions, je crois que je les ai expliquées. Les idées de référence, c'est que le patient est convaincu que des éléments de l'environnement, par exemple la télévision, les vidéos YouTube, dans les réseaux sociaux, lui envoient des messages ou des signes à lui. On parle de lui à la télé.

Le patient peut vous dire carrément, oui, on parle de moi à la télé, on insinue des choses sur moi à la télé. Donc ça, c'est les idées de référence. La pensée magique, c'est comme la pensée des enfants qui s'attribue le pouvoir, par exemple, d'empêcher des événements ou de réaliser des événements.

Le rationalisme morbide, c'est une forme de raisonnement, mais qui est pseudo-logique. Le raisonnement normalement doit être logique, mais là c'est un raisonnement qui est pseudo-logique. Je vais vous donner un exemple.

Un patient qui a un rationalisme morbide peut vous dire, un patient qui entend des voix, qui est malade, qui entend des voix, qui est halluciné, c'est-à-dire qui entend des voix à l'intérieur de sa tête. Pour essayer d'expliquer lui-même, à lui-même, pourquoi il entend ces voix, il va vous dire, eh bien, j'ai mangé des aliments qui sont empoisonnés et vous savez très bien que le poison passe dans le sang. Et vous savez très bien, il va vous dire aussi que vous savez que le sang passe au cerveau.

Donc ce poison est passé dans mon cerveau et ça a entraîné l'apparition de ces voix. Ça c'est un vrai raisonnement morbide, un vrai rationalisme morbide d'un de mes patients. Donc vous

voyez que c'est un raisonnement qui est pseudo-logique.

C'est vrai qu'il utilise quelques éléments scientifiques réels, parce que justement le poison il peut passer dans le sang, mais pour arriver à une fin qui n'est pas logique. Le délire c'est une croyance en une idée erronée, une croyance inébranlable à une idée erronée. Le délire se décrit par son mécanisme.

C'est quoi le mécanisme ? C'est à dire, on va prendre un type de délire, c'est un délire par exemple, on va prendre un délire religieux. Un patient qui vous dit, ou bien on va prendre l'exemple que je vous ai donné, un délire mystique ou religieux, il va vous dire, je suis le prophète. Pour définir le mécanisme, vous allez lui poser la question, comment vous savez que vous êtes le prophète ? Il va vous dire, on s'adresse à moi dans le Coran.

Il va prendre tous les versets coraniques dans lesquels Dieu s'adresse au prophète et va comprendre que Dieu s'adresse à lui, au patient. La systématisation c'est le fait que ce soit un délire logique, compréhensible ou pas. Et on va voir l'intérêt de la systématisation.

(30:35 - 31:16)

Et là, c'est un délire qui n'est pas systématisé. La participation affective, c'est le vécu du patient, le vécu émotionnel du patient par rapport au délire. C'est à dire, comment il vit le fait qu'il est prophète.

Parfois, dans cette situation là, le patient le vit avec euphorie. Il est très content qu'il y ait le prophète. Mais il peut le vivre avec angoisse.

Je ne sais pas pourquoi je suis le prophète. Je suis le prophète, on veut me tuer. Donc il vit ce délire là avec angoisse ou avec peur.

(31:17 - 40:25)

C'est ça la participation affective. Je reviens à la systématisation du délire parce que c'est important. Parfois, on a des patients qui sont délirants.

Mais quand ils vous parlent de leur délire ou quand ils essayent de vous expliquer leur délire, ça apparaît logique. Je vais vous donner un exemple. Dans une pathologie, dans le paranoïa, le patient a l'impression qu'il est le centre d'un vaste complot.

C'est à dire que tout le monde complotte contre lui. Tout le monde lui veut du mal. Tout le monde veut prendre son poste de travail.

Vous lui dites comment vous le savez. Il va vous dire, je n'ai pas reçu de promotion l'année dernière alors que mon collègue qui est moins compétent que moi a eu cette promotion. Quand vous entendez ça, ça paraît logique.

C'est ça un délire systématisé. C'est logique. Mais quand vous demandez, si vous connaissez la

réalité des choses, en fait c'est un patient, votre patient n'est pas aussi compétent ou plus compétent que son collègue.

Mais il interprète tout comme étant un complot contre lui. C'est ça la systématisation. Maintenant on va passer aux troubles de la perception.

Il y a les hallucinations. C'est une perception, c'est-à-dire que le malade perçoit des choses qui n'existent pas, sans objet à percevoir. Il y a les hallucinations psychosensorielles qui intéressent les organes de sens, notamment l'audition, les hallucinations visuelles, gustatives, olfactives, sénesthésiques.

Sénesthésique c'est par rapport au toucher, par rapport à... Le patient peut sentir des fourmis, sensations de fourmissement. Et les hallucinations intra-psychiques qui peuvent être soit des voix, mais à l'intérieur de sa tête, et non pas des voix, des hallucinations auditives, ou bien un type d'image mentale. Sauf que dans les hallucinations, ce qui diffère les hallucinations intra-psychiques aux pensées du patient, c'est qu'il les attribue à quelqu'un d'autre.

Quand vous demandez au patient, ces voix-là que vous entendez à l'intérieur de votre tête, c'est les voix de qui? Est-ce que c'est la voix de votre pensée? Il va vous dire non, c'est la voix de quelqu'un d'autre. Quelqu'un parle à l'intérieur de ma tête. La déréalisation, c'est une perte du sentiment de réalité.

Donc tout devient étrange chez le patient. La dépersonnalisation, c'est un sentiment chez le sujet, chez certains sujets qui ne sont plus eux-mêmes, que leur corps a changé, comme un sentiment de dédoublement, un sentiment de modification corporelle, d'un néantissement psychique, c'est-à-dire qu'il n'est plus là. L'automatisme mental, c'est que les patients ont l'impression qu'ils ne sont plus maîtres de leur motricité ou de leur pensée.

Quand on leur fait faire des choses, on me fait dire des choses, parfois des patients, ils peuvent commettre des actes de violence parce que justement ils ont un certain nombre d'automatismes mentaux. Leur pensée est influencée par une force étrangère qui commande leurs actes. On leur dit, va tuer cette personne, elle te veut du mal, va te suicider et toujours ces pensées et ces voix-là, cette force-là n'est pas considérée par le patient comme étant sa propre force.

C'est une force étrangère, extérieure, ce n'est pas ma voix, c'est quelqu'un qui m'ordonne et qui me commande. Le langage, comme on l'a dit quand on a analysé la pensée, il est le reflet de la pensée. On a parlé de l'atachiphémie, de la mutisme, c'est l'absence totale du langage.

Les productions anormales du langage, comme les stéréotypies, c'est une répétition de certains mots, de certaines phrases, de façon automatique chez certains patients. Le néologisme, c'est la fabrication d'un nouveau mot qui n'existe pas mais qui a un sens pour le patient. Les troubles des fonctions supérieures, je crois que vous les avez vus dans la simbiologie neurologique, mais on va les traiter de façon vraiment succincte, c'est la conscience, la vigilance, l'attention, la

concentration et l'orientation.

Les fonctions amnésiques aussi. Si vous avez des questions concernant les troubles des fonctions supérieures, on va vous les poser et essayer de poser les questions au fur et à mesure s'il vous plaît. Maintenant, on analyse les troubles de l'état émotionnel.

L'émotion, c'est les sentiments éprouvés par une personne en réaction à une situation donnée. Ça peut être la joie, la tristesse, la peur, la colère et autres. Par contre, l'affect, c'est la tonalité des sentiments qui accompagnent une idée.

Est-ce que c'est une tonalité agréable ou désagréable? Rappelez-vous quand on a vu le délire et quand on a parlé de la participation affective, c'est-à-dire que quand votre patient croyait qu'il était le prophète, quand il a dit je suis le prophète, la participation affective, il vit cette idée avec euphorie. Donc c'est ça l'affect, il y a l'euphorie. C'est la tonalité des sentiments qui accompagne une idée.

Dans l'exemple qu'on a vu, c'est l'idée qu'il est le prophète. Donc les troubles de l'affectivité, on peut trouver l'hypérémotivité, c'est des réactions émotionnelles toujours exagérées par rapport à la situation ou le défaut d'émotivité ou l'émotivité inadéquate, c'est une absence d'harmonie entre le discours ou la situation de l'affect exprimé. Par exemple, dans la schizophrénie, vous pouvez avoir des patients qui vous parlent de son père ou de sa mère qui vient de mourir en souriant, en étant avec une tonalité agréable.

Les troubles de l'humeur, c'est l'humeur dépressive, c'est une vision pessimiste du monde et de soi. L'humeur expansive ou euphorique, c'est une vision heureuse du monde avec euphorie sans limite. Et la timide, c'est l'absence de tout affect ou de tout sentiment.

(40:27 - 41:36)

Maintenant, on va passer aux troubles anxieux. La peur, c'est une réaction normale, un danger réel. Il faut savoir que le sentiment de peur, c'est le sentiment qui a permis à l'humanité de rester, qui a permis à l'homme de rester en vie pendant longtemps s'il n'avait pas eu le sentiment de peur des animaux féroces.

Parce que le sentiment de peur est accompagné par un cortège de comportements, c'est-à-dire le comportement de la fitte. S'il n'a pas ce sentiment de peur en voyant un lion, il ne va pas prendre la fitte, il ne va pas essayer de se défendre et il va mourir. Par contre, l'anxiété, c'est une vigilance douloureuse avec attente pénible d'un danger.

(41:38 - 41:58)

C'est un danger qui n'est pas précis par le patient. C'est ça l'anxiété. Et l'anxiété généralisée, c'est une anxiété qui est flottante, qui concerne tous les domaines de la vie.

(41:58 - 42:45)

Elle est généralisée à tous les domaines de la vie. Il n'y a pas un seul objet d'anxiété du patient. Dans les troubles anxieux, il y a les troubles phobiques.

L'anxiété est fixée sur un objet, sur une situation. Rappelez-vous quand on a vu la phobie des chats, la phobie de conduire une voiture, la phobie de prendre l'avion, etc. Obsessionnel, on a expliqué.

Hypochondriaque, l'anxiété est fixée sur la santé du patient. Le patient a le sentiment qu'il est atteint d'une maladie grave. A chaque symptôme qu'il présente, il l'attribue à une maladie grave.

(42:45 - 43:04)

Par exemple, si ce patient a des céphalées, il va se dire, mon Dieu, peut-être que je fais un cancer du cerveau. Et il le vit avec douleur, avec angoisse. Traumatique, c'est la reviviscence d'un traumatisme ancien.

(43:05 - 43:40)

Il faut savoir que dans l'anxiété traumatique ou dans l'état de stress post-traumatique, c'est une maladie qui survient après un traumatisme, on va prendre l'exemple d'un traumatisme grave. Après, par exemple, un accident de la voie publique très grave, où il y avait beaucoup de morts, par exemple, où le patient a failli mourir. Les patients qui ont un état de stress post-traumatique ont ce qu'on appelle le sentiment de reviviscence.

(43:40 - 44:03)

C'est-à-dire qu'ils peuvent revivre mentalement l'événement traumatique avec tous ces sentiments de peur, d'angoisse, même ces sentiments douloureux, ils peuvent les revivre. C'est ça ce qu'on appelle la reviviscence. Maintenant, on va passer à l'insight et le jugement.

(44:03 - 45:05)

L'insight, c'est la conscience du trouble, c'est-à-dire la conscience qu'on est malade ou pas, et l'attribution de ces troubles à une maladie. Par exemple, vous avez un patient qui a des hallucinations auditives, d'accord? La conscience du trouble, c'est le fait qu'il est conscient qu'il a des hallucinations, qu'il a des voix, d'accord? Et l'attribution de ces troubles, c'est la conscience des causes et du sens de ces troubles, c'est l'attribution de ces hallucinations à sa maladie. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ces hallucinations-là, ces voix-là sont dues à ma maladie, sont dues à la schizophrénie que j'ai.

(45:06 - 46:02)

Un défaut d'insight, dans un défaut d'insight, le patient peut vous dire, ces voix-là que j'entends sont dues à l'ensorcellement, ils sont dus à un empoisonnement, d'accord? Le jugement, c'est la capacité de prendre une décision de façon correcte et socialement

acceptable. De façon pratique, comment vous allez organiser votre observation? Vous allez voir qu'il y a certaines particularités à l'observation en psychiatrie. D'abord, on commence toujours par l'identité et les données démographiques, nom, âge, profession, statut marital.

(46:04 - 46:25)

Et le motif de consultation, on met dans le motif de consultation, on met la plainte principale du patient ou les plaintes principales. Parce que les patients peuvent avoir une ou plusieurs plaintes. Et dans le motif de consultation, on doit noter les mots exacts du patient.

(46:26 - 46:42)

Parce que ça reflète l'attente du patient. Un patient qui vient vous voir pour des céphalées, le motif de consultation, c'est des céphalées. Parce qu'en venant vous voir, parce que vous allez voir en cinquième année que dans la dépression, on peut trouver les céphalées.

(46:43 - 47:12)

Donc c'est un patient qui vient vous voir pour les céphalées et non pas pour la dépression, parce qu'il ne sait pas qu'il est déprimé. Donc son but, ses attentes, c'est que ces céphalées-là disparaissent. L'histoire de l'épisode actuel, est-ce qu'il y avait ou pas des facteurs déclenchants? Par exemple, les facteurs des événements de vie, un deuil, un déménagement, une rupture sentimentale et autres.

(47:13 - 48:04)

Un divorce, la date de début des troubles, le mode de début, c'est-à-dire sur quel mode le trouble est apparu. Sur un mode aigu, c'est-à-dire sur quelques jours, il a présenté ces symptômes-là ou bien sur plusieurs mois. L'évolution, est-ce que c'est un trouble qui va en s'aggravant? La durée, quels sont les symptômes et les signes que présente le malade? Et les effets de l'épisode ou de ces symptômes sur le sujet lui-même, ça peut causer par exemple un licenciement de son travail, ça peut causer un divorce, ça peut causer des problèmes avec la famille.

(48:04 - 48:42)

Et ces symptômes-là, est-ce qu'ils étaient une cause de souffrance pour le patient et quel est le degré de cette souffrance? Et après, on passe à l'histoire de la maladie générale, c'est-à-dire la différence entre épisodes et maladies. Vous savez que la schizophrénie est une maladie chronique qui évolue par épisode. Des épisodes où la maladie devient plus marquée et plus grave.

(48:43 - 49:07)

Mais entre les épisodes, le patient nécessite toujours la prise de traitement. Donc c'est une maladie chronique. On peut commencer soit par l'histoire de la maladie de façon générale, soit

on commence par l'histoire de l'épisode actuel, de la poussée actuelle, et après on passe à l'histoire de la maladie.

(49:09 - 50:02)

Dans l'histoire de la maladie, on détermine est-ce que le patient a été déjà hospitalisé ou pas, est-ce qu'il a bénéficié de traitements, de consultations, et quelle est l'évolution de la maladie. Est-ce qu'il y avait une bonne évolution sous traitement ou pas? Les antécédents du patient, antécédents psychiatriques, médicaux, chirurgicaux, toxiques, c'est-à-dire est-ce qu'il prend des substances psychoactives comme le cannabis, les drogues, parce que les substances toxiques peuvent aggraver la maladie. Ces antécédents judiciaires, est-ce que c'est un patient qui a la tendance à la violence? C'est pour ça que c'est important de noter dans le dossier médical les antécédents judiciaires.

(50:04 - 51:30)

Antécédents judiciaires, c'est-à-dire antécédents d'emprisonnement pour un motif particulier. La biographie du patient correspond à son histoire personnelle depuis l'enfance, depuis la grossesse d'abord. Est-ce que c'était une grossesse désirée ou pas? La naissance, la première enfance, est-ce que c'est la grossesse et accouchement, est-ce qu'il n'y avait pas de signe de souffrance néonatale? Est-ce que la maman n'était pas malade lors de la grossesse? La naissance et la première enfance, comment l'enfant l'a passé? Est-ce que c'était une enfance heureuse? Est-ce que c'était un enfant désiré, abandonné? Est-ce qu'il y avait la notion de séparation avec les parents? Pour l'enfance et l'adolescence, l'apprentissage et la scolarité, est-ce qu'ils étaient bons? Est-ce que c'était un enfant qui n'avait pas de problème avec ses camarades de classe? Est-ce que ce n'était pas un enfant turbulent dans la vie adulte? On analyse la vie sociale, est-ce que le patient a des amis? Est-ce qu'il a des relations familiales affectives? Est-ce qu'il a une petite amie? Est-ce qu'il est marié? Comment est sa relation avec sa femme? Et on analyse aussi la sexualité du patient.

(51:30 - 52:26)

Est-ce que c'était une sexualité normale? Est-ce qu'il y avait des perversions sexuelles en l'âge adulte? Parce que tous ces éléments-là ont une importance primordiale dans les diagnostics à évoquer. Parce qu'un patient qui a des perversions sexuelles et qui est en retrait, qui est isolé, qui n'a pas d'amis, qui ne travaille pas, qui avait un problème de scolarité et d'apprentissage, ça peut nous orienter vers une pathologie comme par exemple la psychose, la schizophrénie. Et on analyse aussi l'histoire familiale.

(52:26 - 52:50)

Est-ce qu'il y a des pathologies chez la famille? Est-ce qu'il y a la notion de traumatisme psychique? Familial. L'état mental actuel, c'est-à-dire qu'on va analyser, on va faire l'analyse stémiologique, la présentation, le comportement, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'appréciation de

la personnalité, du type de personnalité.

(52:52 - 53:19)

Est-ce que c'est une personnalité évitante, schizotypique, schizouite? L'appréciation de la personnalité, vous allez la voir au cours de 5e année des troubles de la personnalité. On peut utiliser des questionnaires pour, il faut savoir qu'il y a des questionnaires pour la dépression. Il y a le DSM dont je vous ai parlé au début de la séance.

(53:20 - 53:53)

On utilise aussi l'imagerie, le scanner. Il faut savoir que devant tout patient qui présente un délire ou des hallucinations, une IRM ou un scanner sans importance, sans primordial. Il faut savoir aussi qu'il n'y a aucun examen complémentaire, soit un bilan de sang, soit de l'imagerie ou un bilan biologique, ne confirme une maladie psychiatrique.

(53:53 - 54:25)

La maladie psychiatrique est évoquée et confirmée par un cortège de critères cliniques surtout. On fait la conclusion clinique, notre conclusion, la discussion diagnostique. Dans la conclusion, on met déjà, on prend les principaux symptômes et on les regroupe en syndrome et on commence, on s'attaque à notre discussion diagnostique, diagnostique à évoquer.

(54:26 - 56:16)

Quels sont les éléments pour ou contre ces éléments, la conduite à tenir et l'évolution et le pronostic de la maladie. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez pas de questions, prière de me répondre, de me dire que vous n'avez pas de questions.

Oui, vous n'allez avoir que ce cours-là pour cette année, oui. Oui, Ali, on n'a que ce cours. Vous l'avez dans la plateforme, n'est-ce pas? D'accord.

Oui, on n'a que ce cours-là. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un très bon courage pour l'examen. Pour mes questions, moi, je les pose toujours sur les diapositives.

Donc, les propositions et les questions sont sur le cours, les diapositives et pas plus que ça. Je vous remercie pour votre attention et on se voit, incha'Allah, en cinquième année, quand vous serez pour la pathologie psychiatrique, incha'Allah. Merci beaucoup.

Merci à vous. Au revoir.